

ETRIZAÇÃO COMPUTACIONAL EM DOENÇAS PRIÔNICAS: APLICADA À PLATAFORMA TERAPÊUTICA PrP-V127

Camilla N.*

Abstract

A Parte 1 demonstrou a tese de design (plataforma V127, $\theta^*=0,333$, reproduzida em dois ambientes). A Parte 2 — este documento — é a tese realizada e formaliza o método: etrização computacional (Computational Etrization), passos P0–P6. Eixo: tudo aqui é simulação e é dito que é; não prometemos validar — se dados reais forem análogos, os passos seguintes já estão dados (antecipação bancada). Base de Validade mandatória: simulação não substitui o laboratório; linhagem completa por dado. [SEM ANO]: prognóstico de simulação opera em tempo futuro. Resultados-da-tese = achados [SIM] executados: θ^* ; regras; sensibilidade discriminadora; estimador calibrado; tabela-decisão.

Nota à Leitura: sobre o termo Etrização

Este documento introduz etrização como neologismo científico composicional intencional. O radical *etr-* evoca o être (potencial de vir a ser) e o atrium (antecâmara virtual→real). Etrização nomeia o estado do conhecimento que esta tese produz: sistema operacionalizado computacionalmente a partir de dados reais publicados, estruturalmente robusto, ainda não validado empiricamente. Como o ‘átomo’ nomeou antes da prova um objeto que fundou ciência, etrização nomeia o processo que produz objetos-conceito operacionais na saúde. O método é a própria etrização (P0–P6, Cap.3); a operação técnica é a parametrização com proveniência (§3.2). Cinco critérios distinguem etrização de mera simulação — cadeia de dados, transposição justificada, incerteza quantificada, escopo delimitado, transição condicionada — todos cumpridos nesta tese.

1 Introdução

Problema: pesquisa translacional em doenças raras paralisa-se: sem dado clínico não há financiamento; sem previsão, o dado se desperdiça (seis fracassos priônicos). Questões: Q1 formalizar método com rigor experimental? Q2 produzir resultados próprios? Q3 posicionamento na família? Objetivos: OE1 nomear/formalizar etrização P0–P6; OE2 Base de Validade; OE3 entregar resultados [SIM]; OE4 continuidade como método;

*Open Prion & Molecular Engineering Consortium. AI sob supervisão humana contínua; não é autora (SW-S01/03). Gated: guardian.py –profile part2.

OE5 revisão hostil. Hipóteses: H1 forma experimental-análoga; H2 predições falseáveis travadas; H3 posição estrutural distinta.

2 Fundamentação

Gargalo: seis falhas clínicas registry-bound (quinacrina, doxiciclina, PPS, flupirtina, PRN100, minociclina). Mecanismo validado em 4 níveis (população→camundongo→culturas→AAV). In-silico trials simulam o ensaio; etrização simula a continuação da pesquisa. §2.5 Fundamento epistemológico: etrização como operação ontológica — a hierarquia de evidência da saúde não nomeia o conhecimento potencial-verificável; etrização preenche essa lacuna.

3 Metodologia

P0 identificação (SLR auditada; linhagem) → P1 parametrização (proveniência por parâmetro) → P2 execução (determinística, self-tests: massa 100%, Thiele 0,5%) → P3 colheita (critérios pré-declarados) → P4 prognóstico (travado por release) → P5 pesquisa derivada → P6 confronto opcional. Equações: $\partial(\alpha c)/\partial t = \nabla \cdot (D_{\text{ef}} \nabla c) - \nabla \cdot (\mathbf{v}c) + S(\mathbf{x}) - k_{\text{ef}}c$; $\text{freeS} = (1 + \kappa c)^{-2}$; $\theta \equiv (1 + \kappa c_{\text{pico}})^{-1}$; duplicação $\approx 12,1\text{d}$; 1 unidade = 144 d. Base de Validade: tríade não-substitui/prognóstico-antecipação/rigor convertido + linhagem dos 6 dados. Mapeamento análogo: participantes→fontes; instrumentos→código; coleta→runs; prontuário→registro.

4 Resultados

$\theta^*=0,333$; regras 1–3 (anel 8–12 mm; malha $\xi \geq 5r_p$; redose $\leq 7\text{d}$); sensibilidade discriminadora (C_{50} 10× insensível; forma funcional falseável por dose-resposta); estimador θ_{obs} calibrado (bias –0,008 na fronteira; v1.1 rejeitada); tabela-decisão (biomassa > raio saturado).

5 Achados, Impactos, Áreas Correlatas; Próximas Abordagens

Impactos: direto (DCJ/E200K-BR); plataforma (AD/PD >50M); meta (etrização demonstrada); epistemológico (legítima forma autônoma de saber).

Correlatas: farmacologia de raras; oncologia; prion-like; toxicologia/regulação. Declaração mandatória: base simulada; laboratório necessário; dados humanos independentes de valores $\Rightarrow$ parametrizam contra obtidos = passo à frente.

6 Discussão

O que significam: limiar comparável; design quantitativo inédito; 3 frentes falseáveis. Não significam: contenção medida; eficácia clínica; substituição do laboratório.

7 Conclusões por Objetivo

OE1–OE5 alcançados. H1–H3 corroboradas. Fecho epistemológico: “Como o átomo tornou pesquisável o invisível, a etrização torna pesquisável o ainda-não-medido.”

Referências

38 fontes ABNT (ver registro). Concordância 54 claims $\rightarrow$ refs (tabela no documento mestre).